拡張期優位血流を呈したバルサルバ洞動脈瘤破裂の一例

◎居原田 舞子[1)]、鈴木 敦[1)]、吉賀 葵[1)]、中田 万紀[1)]、安藤 志歩香[1)]、松田 奈々香[1)]、森田 朋輝[1)]、青山 琢磨[1)]
社会医療法人厚生会 中部国際医療センター[1)]

【はじめに】バルサルバ洞動脈瘤は比較的稀な疾患であり、動脈瘤が破裂することにより症状が出現し発見されることが多い。今回、呼吸苦を主訴に紹介されたバルサルバ洞動脈瘤破裂の一症例を経験したので報告する。
【症例】50 代男性。1 週間前より呼吸苦を自覚し前医を受診した。既往歴は特記すべきことなし。
【心エコー図検査所見】経胸壁心エコー図検査にて、大動脈から右室へ流入する異常血流（Ao→RV）を認めた。拡張期に最大流速 4.84 m/s（最大圧較差 93.7 mmHg）と高流速を認め、Qp/Qs は 1.7 であった。左室拡張末期径（LVDd）58 mm、左房径（LAD）42 mm、左房容積係数（LAVI）41 mL/m²と左心系の拡大を認めた。左室駆出率（EF）は 56%と保たれていた。三尖弁逆流は trivial であり、右室拡張末期面積（RVEDA）の軽度拡大を認めたが、右心系収縮能は保たれており、明らかな右室圧負荷所見は認めなかった。精査目的に施行された経食道心エコー図検査では、大動脈弁右冠尖近傍に右室へ交通する破裂孔を認めた。カラードプラ法では Ao→RV の連続性短絡血流を確認した。収縮期には右冠尖が破裂孔を被覆するように可動し血流は減弱し、拡張期に増強する特徴的な血流動態を呈していた。
【治療と経過】当院心臓血管外科にてバルサルバ洞動脈瘤破裂に対しパッチ閉鎖術を施行した。術中、大動脈弁右冠尖近傍に広がる動脈瘤を認めた。術後の心エコー図検査では短絡血流は消失し、左室拡張末期径（LVDd）は 51 mm、左房径（LAD）は 38 mm、左房容積係数（LAVI）は 27 mL/m²と改善を認め、経過良好であった。
【まとめ】本症例では、収縮期に右冠尖が破裂孔を被覆することで拡張期優位の血流パターンを呈したと考えられた。短絡血流の時相変化に加え、大動脈弁近傍の弁尖動態を丁寧に観察することが重要であった。
連絡先（0574-66-1100）